

分子標的治療薬

分類・作用点・副作用・病院と薬局の確認ポイントを図解で

1 薬剤の分類マップ

小分子TKI(経口) 細胞内のキナーゼを阻害	EGFR・ALK(肺癌) オシメルチニブ アレクチニブ ロルラチニブ BCR-ABL(白血病) イマチニブ ダサチニブ ニロチニブ マルチキナーゼ レンバチニブ ソラフェニブ レゴラフェニブ
抗体薬(注射) 細胞外の受容体・リガンドに結合	抗HER2抗体 トラスツズマブ ペルツズマブ 抗EGFR抗体 セツキシマブ パニツムマブ 抗VEGF・VEGFR-2抗体 ベバシズマブ ラムシルマブ
抗体薬複合体(ADC) 抗体で運び細胞内で薬剤を放出	抗HER2 ADC T-DM1 T-DXd その他のADC ダトポタマブ デルクステカン エンホルツマブ ベドチン ボラツズマブ ベドチン
その他の経口標的薬 細胞周期・DNA修復などを阻害	CDK4/6阻害薬 バルボシクリブ アベマシクリブ PARP阻害薬 オラパリブ ニラパリブ mTOR阻害薬 エベロリムス

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い)☐ 注射薬

2 代表的な薬剤群の副作用とモニタリング

薬剤群	代表薬	特徴的な副作用	モニタリング(薬局で確認できること)
EGFR阻害薬	オシメルチニブ・アファチニブ	ざ瘡様皮疹・爪囲炎・下痢・ILD	皮膚症状、排便回数、咳・息切れ
ALK阻害薬	アレクチニブ・ロルラチニブ	筋肉痛・CK上昇/脂質異常症・気分変化	筋肉痛、脂質の検査値、気分の変化(家族にも)
マルチキナーゼ阻害薬	レンバチニブ・レゴラフェニブ	高血圧・蛋白尿・手足症候群・肝障害	家庭血圧、尿蛋白、手足の症状、肝機能値
抗HER2療法	トラスツズマブ・T-DXd	心機能低下/間質性肺疾患	息切れ・むくみ、心エコーの予定、咳
CDK4/6阻害薬	バルボシクリブ・アベマシクリブ	好中球減少/下痢	血液検査値、排便回数、発熱
PARP阻害薬	オラパリブ・ニラパリブ	貧血・悪心(ニラパリブは血小板減少・高血圧も)	息切れ・ふらつき、血液検査値、血圧

3 副作用の特徴と発現時期

	開始日	1週	2週	1か月	3か月	半年～
● インフュージョンリアクション(抗体薬)	投与中～24時間					
● 下痢(アベマシクリブ・EGFR阻害薬)	開始数日～2週					
● ざ瘡様皮疹(EGFR阻害薬)		1～2週で出現				
● 高血圧(血管新生阻害薬)		開始数週				
● 手足症候群(マルチキナーゼ阻害薬)		開始1か月以内に多い				
● 爪囲炎(EGFR阻害薬)				1～2か月以降		
● 心機能低下(抗HER2療法)				治療期間を通じて		
● 間質性肺疾患				時期を問わず起こりうる		

☒ 重篤・特に注意☐ その他

押さえておきたいポイント

- 分子標的薬は小分子(経口)・抗体(注射)・ADCに分かれ、経口TKIは相互作用が多い
- 副作用は標的分子の生理機能を反映(EGFR=皮膚・下痢、VEGF=血圧・蛋白尿、HER2=心機能)
- 経口TKIの服用時点・相互作用・服薬継続の支援は、保険薬局が最も力を発揮する領域